

L'incontinence urinaire d'effort (IUE) chez l'homme correspond à des fuites d'urine lorsque la pression sur la vessie augmente soudainement — en toussant, en se levant, en soulevant un objet ou lors d'une activité. Chez l'homme, elle est presque toujours due à l'affaiblissement du muscle de contrôle urinaire (sphincter) après une **chirurgie de la prostate** ou une radiothérapie. Elle s'améliore souvent durant la première année, et lorsque ce n'est pas le cas, des traitements très efficaces sont disponibles.

À propos de cette affection

Après l'ablation de la prostate, le **sphincter urinaire** principal (la valve qui retient l'urine) assume l'essentiel du travail, et il peut être affaibli. Il en résulte des fuites à l'effort — de quelques gouttes nécessitant une protection, jusqu'à des fuites plus importantes. Cela diffère des fuites par **urgenterie** (envie soudaine et irrépressible d'uriner), qui se traitent différemment ; certains hommes présentent les deux types.

Causes

- **Prostatectomie radicale** (ablation de la prostate pour cancer) — cause la plus fréquente
- Autres interventions sur la prostate ou **radiothérapie pelvienne**
- Plus rarement, affections nerveuses ou vésicales

Les fuites sont généralement **plus importantes au début** et s'améliorent en quelques semaines à quelques mois, à mesure que la cicatrisation et la force du plancher pelvien progressent.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuite d'urine sous pression — en toussant, en se levant, en soulevant.

Sphincter

La valve musculaire qui retient l'urine jusqu'à ce que vous souhaitiez uriner.

Prostatectomie

Ablation chirurgicale de la prostate, cause habituelle de l'IUE masculine.

Plancher pelvien

Les muscles que vous travaillez pour mieux contrôler l'urine.

Test à la protection

Compter le nombre de protections par jour pour mesurer les fuites.

Bandelette masculine

Un soutien placé sous l'urètre pour les fuites légères à modérées.

Ballonnets ProACT

Deux ballonnets ajustables placés près de l'urètre, réglés en consultation ; option peu invasive.

Sphincter urinaire artificiel

Dispositif implanté (manchette contrôlée par l'utilisateur) pour les fuites modérées à sévères.

EST-CE QUE ÇA VA S'AMÉLIORER ? Souvent, oui — les fuites après une chirurgie de la prostate s'améliorent généralement au cours des 6 à 12 premiers mois, surtout avec les exercices du plancher pelvien. Si des fuites gênantes persistent au-delà d'environ un an, c'est le moment d'envisager une bandelette, des ballonnets ajustables ou un sphincter artificiel — qui donnent tous d'excellents résultats.

Comment on le diagnostique

- Un entretien sur le moment et la quantité des fuites (souvent comptées en **protections par jour**)
- Une **analyse d'urine** et un contrôle de la qualité de la vidange vésicale
- Avant une intervention : un examen de l'urètre (cystoscopie) et parfois un bilan urodynamique

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Exercices du plancher pelvien** (Kegels), idéalement commencés autour de la période de la chirurgie, avec gestion des liquides et du poids.
- 2 **Surveillance et amélioration progressive** durant la première année, avec protections selon les besoins.
- 3 **Bandelette masculine** — pour les fuites légères à modérées persistantes (sans antécédent de traitement).
- 4 **Ballonnets ajustables ProACT** — autre option peu invasive pour les fuites légères à modérées ; deux petits ballonnets sont réglés en consultation sur plusieurs visites (déconseillés après radiothérapie).
- 5 **Sphincter urinaire artificiel (AUS)** — la référence pour les fuites modérées à sévères, et le choix après radiothérapie. Chacun dispose de sa propre fiche d'information.

Vivre avec l'IUE masculine

- Faites régulièrement vos exercices du plancher pelvien — c'est la base.
- Utilisez des protections ou un sous-vêtement protecteur pour garder confiance pendant la récupération.
- Limitez les liquides le soir et la caféine si les fuites nocturnes posent problème.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Des brûlures, de la fièvre ou du **sang dans les urines** (possible infection)
- Une incapacité soudaine à **uriner**
- Des fuites qui s'aggravent plutôt que de s'améliorer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'IUE masculine est presque toujours due à un sphincter affaibli après une chirurgie de la prostate ou une radiothérapie — et elle s'améliore généralement durant la première année.
2. Les exercices du plancher pelvien sont la base ; en cas de fuites persistantes, une bandelette masculine ou un sphincter urinaire artificiel donnent d'excellents résultats.
3. Accordez jusqu'à un an à la récupération avant d'envisager une intervention. Appelez en cas de fièvre, de sang dans les urines ou d'impossibilité d'uriner.